

العمر (تاريخ الميلاد) : 07-04-1973 **المهنة :** ربه منزل

التوقيع: (_____)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / ۲ ----- / ۲ ----- / ۲. | ----- / ۲. |

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى : قسم :
 جهة العلاج : نفقات :
 ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: روزماری میشل فخری توفیق National ID: 27304072601522	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

روزماری
ميشيل فخرى توفيق

الميناء - مساكن بنك الاسكان
أول الفرقة - البحر الاحمر

١٩٧٣/٠٥/٢٧

٢٧٣.٤٠٧٢٦.١٥٢٢

J08088652

١٤٨٣٨٧٣٧٦٣



٢٠٢٢/٠٩

٢٧٣.٤٠٧٢٦.١٥٢٢

ربة منزل

متروجة

مسيحية

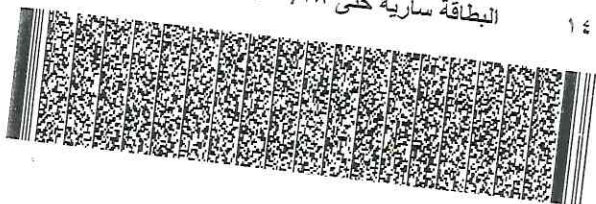
أنثى

نبيل حلمى عزيز بطرس

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١٨



١٤





رسوم الاستعلام 20 جنية

جيهه الاصدار :منطقة البحر الاحمر

تاريخ الاصدار :2026-9-23

الى من يههمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيله .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) روز ماري ميشيل فخري توفيق بطاقة رقم 27304072601522
تليفون رقم: 01283873763

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة :2026-9-23

الموظف المختص

مشيره هشام

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،



مسلسل 2088031

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى



L A B S

Collection Date: 13/09/2026

Review Date: 20/09/2026

Referring Doctor: أ.د محمد فتحي

Patient Name: الاستاذة/ روز ماري ميشيل فخري

Patient No.: 136-29141

Accession No.: 13626097490

Age: 53Y

PATHOLOGY UNIT

Path.No. : (14305-26)

Clinical Data & Nature of the specimen:

Right breast mass, TCNB.

Gross Examination:

Multiple (4) brown focally yellow tissue cores longest measured 1.6 cm, totally submitted.

Grossing by A. Abdelwahed

Microscopic Examination:

Histological Type: Invasive Duct (NST) Carcinoma, with cluster of cells with plasmacytoid features.

Histological Grade: (2)

Nottingham score: Tubular differentiation (2) + Nuclear Pleomorphism (2) + Mitosis (2).

In situ component: Absent.

Lymphovascular emboli: Inconspicuous.

Necrosis: Absent.

Microcalcification: Absent.

Diagnosis:

Right breast mass. TCNB:-

*Invasive duct carcinoma (NST), Grade (2) with minimal foci suspicious for associated lobular component, for (E-Cadherin) IPT.

*Royal collage (B5)

*For correlation with clinical & radiological findings

N.B:-

Royal collage of pathologists breast lesions reporting categories include the following:-

B1. Normal tissue.

B2. Benign lesion.

B3. Lesion of uncertain malignant potential.

B4. Suspicious lesions.

B5. Malignant lesions.

Prof. Dr. Riham Abu-Zeid, MD

Prof. Dr. Sahar Daoud, MD

Pt. Branch: وحدات الرنيني

Page 1 of 2

Printed by: 3492 حسام محمد احمد محمد



Collection Date: 13/09/2026
Review Date: 20/09/2026

الاسم: روز ماري ميخيل فخري
Patient Name: روز ماري ميخيل فخري
Patient No.: 136-29141
Accession No.: 13626097490
Age: 53Y

أ. د. محمد قتي
Referring Doctor:

PATHOLOGY UNIT

Path.No. : (14305-26)

Clinical Data & Nature of the specimen:
Right breast mass, TCNB.

Gross Examination:

Multiple (4) brown focally yellow tissue cores longest measured 1.6 cm, totally submitted.

Grossing by A. Abdelwahed

Microscopic Examination:
Histological Type: Invasive Duct (NST) Carcinoma, with cluster of cells with plasmacytoid features.

Histological Grade: (2)

Histological Grade: (2)

Nottingham score: Tubular differentiation (2) + Nuclear Pleomorphism (2) + Mitosis (2).

Insitu component: Absent.

Lymphovascular emboli: Inconspicuous.

Necrosis: Absent.

Microcalcification: Absent.

Diagnosis:

Right breast mass, TCNB:-

* Invasive duct carcinoma (NST), Grade (2) with minimal foci suspicious for associated lobular component, for (E-Cadherin) IPT.

* Royal collage (B5)

* For correlation with clinical & radiological findings

N.B:-
Royal collage of pathologists breast lesions reporting categories include the following:-

B1. Normal tissue.

B2. Benign lesion.

B3. Lesion of uncertain malignant potential.

B4. Suspicious lesions.

B5. Malignant lesions.

Prof. Dr. Riham Abu-Zeid, MD

Prof. Dr. Sahar Daoud, MD

وحدة التفتيش: PT

Page 1 of 2

3492
Printed by: محمد احمد محمد

Patient name: Mrs. ROSEMARRY MESHL FAKHRY

Referring Prof. Dr.

Date: 21/9/2026

BOTH BREASTS MAMMOGRAPHY REPORT

BOTH BREASTS MAMMOGRAPHY REPORT

** Mammography (Cranio-caudal & medio-lateral oblique views):

- Dense mass lesion seen in the lower outer quadrant of the Rt. Breast, it shows irregular spiculated outline.
- Normal Lt. breast density with normal distribution of breast fat. No dominant masses or abnormal opacities seen.
- No evidence of micro or macro-calcifications.
- Normal skin thickness and breast contour.
- Normal appearance of nipple-areolar complex.
- Enlarged Rt. axillary LNs.

IMPRESSION:
HIGHLY SUSPICIOUS RT. BREAST MASS LESION WITH
PATHOLOGICAL RT. AXILLARY LN. FOR BIOPSY.

Sincerely,

Prof. Dr. Mustafa El Sharkawy



CSR



Dr. Mohamed Fathy

Ultrasound and Doppler unite

Name: Rosemarry Beshay

Date : 12/09/2026 11:07 PM

Bilateral Breast Ultrasonography

- The right breast shoed a well defined hypoechoic solid lesion measuring 22x14x16 mm located at (6-7) o'clock showing irregular outlines associated with ipsilaterally enlarged axillary lymph nodes with malignant nature , the largest one measures 22x14 mm .
- Normal sonographic appearance of left breast with homogeneous texture. No solid / cystic lesions.
- No dilated ducts .
- Normal appearance of nipple, areola, skin & subcutaneous tissues
- Few benign looking left axillary lymph nodes are detected

Conclusion:

- **Right breast mass (BIRADS V) with ipsilateral malignant looking lymph nodes for biopsy.**

Much Obfged Yours

Dr. Mohamed Fathy



L A B S

Collection Date: 13/09/2026
Review Date: 20/09/2026

الاستشارة روز ملاري ميشيل فكري
Patient Name: الاستشارة روز ملاري ميشيل فكري
Patient No.: 136-29141
Accession No.: 13626097490
Age: 53Y

Referring Doctor: أ.د. محمد فتحي

PATHOLOGY UNIT

Path.No. : (14305-26)

Clinical Data & Nature of the specimen:

Right breast mass, TCNB.

Gross Examination:

Multiple (4) brown focally yellow tissue cores longest measured 1.6 cm, totally submitted.

Grossing by A. Abdelwahed

Microscopic Examination:

Histological Type: Invasive Duct (NST) Carcinoma, with cluster of cells with plasmacytoid features.

Histological Grade: (2)

Nottingham score: Tubular differentiation (2) + Nuclear Pleomorphism (2) + Mitosis (2).

In situ component: Absent.

Lymphovascular emboli: Inconspicuous.

Necrosis: Absent.

Microcalcification: Absent.

Diagnosis:

Right breast mass. TCNB:-

*Invasive duct carcinoma (NST), Grade (2) with minimal foci suspicious for associated lobular component, for (E-Cadherin) IPT.

*Royal collage (B5)

*For correlation with clinical & radiological findings

N.B:-

Royal collage of pathologists breast lesions reporting categories include the following:-

B1. Normal tissue.

B2. Benign lesion.

B3. Lesion of uncertain malignant potential.

B4. Suspicious lesions.

B5. Malignant lesions.

Prof. Dr. Riham Abu-Zeid, MD

Prof. Dr. Sahar Daoud, MD

وحدة المختبر: المختبر

Page 1 of 2

Printed by: 3492

MRS. ROSEMARY MESHIL FAKHRY

Patient name: Mrs. ROSEMARY MESHIL FAKHRY
Referring Prof. Dr.

Date: 21/9/2026

BOTH BREASTS MAMMOGRAPHY REPORT

Mammography (Cranio-caudal & medio-lateral oblique views):

- Dense mass lesion seen in the lower outer quadrant of the Rt. Breast, it shows irregular spiculated outline.
- Normal Lt. breast density with normal distribution of breast fat. No dominant masses or abnormal opacities seen.
- No evidence of micro or macro-calcifications.
- Normal skin thickness and breast contour.
- Normal appearance of nipple-areolar complex.
- Normal appearance of axillary LNs.
- Enlarged Rt. axillary LNs.

IMPRESSION:

**HIGHLY SUSPICIOUS RT. BREAST MASS LESION WITH
PATHOLOGICAL RT. AXILLARY LN. FOR BIOPSY.**

Sincerely,

Prof. Dr. Mustafa El Sharkawy



HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنيهة

تاريخ الإصدار: 2026-9-23

جبه الإصدار: منطقة البحر الأحمر

الى من يهمله الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للائتماع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحت تبين أن

السيد (ة) روز ماري ميشيل فخري توفيق بطاقة رقم 27304072601522
تليفون رقم: 01283873763

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
وعتبر من الغات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون الذي مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطابعه: 2026-9-23

الموظف المختص

مشير د هشام

شكرا

إفادة مركز نظم المعلومات



مسلم 2088031



الخطيب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا أنه خلاله يقتصر خلاله المواطن من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية و التعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي